

Examen du périnée, gynécologique et uro-génital

Table des matières

1) Examen du périnée.....	1
0) Anatomie.....	1
1.1) Anamnèse.....	2
1.2) Inspection.....	3
1.3) Palpation.....	3
(1.4) Investigations supplémentaires).....	4
1.5) Tableaux cliniques typiques.....	4
2) Examen gynécologique.....	6
3) Examen uro-génital.....	7
3.1) Anamnèse.....	7
3.2) Examen chez la femme.....	9
3.3) Examen chez l'homme.....	9
3.4) Tableaux cliniques typiques.....	10

1) Examen du périnée

0) Anatomie

On retrouve 3 compartiments dans le périnée :

- Antérieur : composé de la vessie et de l'urètre (et de la prostate chez les hommes), il appartient aux urologues
- Moyen : composé du vagin et de l'utérus, il appartient aux gynécologues
- Postérieur : composé du rectum, il appartient aux chirurgiens viscéraux

Le plancher pelvien est très similaire chez l'homme et la femme : il est majoritairement composé de muscles (transverses superficiel et profond du périnée, pubo-rectal, ischio-caverneux, releveur de l'anus, sphincters interne et externe) accompagnés de leurs fascia, de ligaments (ano-coccygien principalement) et d'espaces morts (fosse ischio-rectale, souvent touchée par les abcès). Les femmes ont souvent plus de problèmes que les hommes en ce qui concerne le périnée, car elles peuvent avoir des grossesses et parfois des épisiotomies avec.

Rectum, canal anal et marge anale :

- Rectum : partie la plus profonde, elle est couverte d'épithélium intestinal
- Canal anal : partie intermédiaire, il est couvert d'un épithélium de transition vers le rectum et d'un EPPNK vers la marge anale. Près de son milieu, on retrouve la ligne dentée (donne la limite entre les épithélia), lieu où se situent les glandes cryptoglandulaires, souvent à l'origine de fistules. En-dessus et en dessous de cette ligne (= dans tout le canal anal), on retrouve des hémorroïdes, physiologiques, qui sont des

coussinets artério-veineux indispensables pour nous permettre de garder notre continence des gaz ; s'ils prolapsent hors de l'anus, on parle de maladie hémorroïdaire

- Marge anale : marge de ~ 5cm d'épithélium pluristratifié kératinisé, comme la peau normale. C'est dans cette zone qu'on retrouvera les veines péri-anales, qui si elles thromboses donnent des thromboses veineuses péri-anales, qui ne sont pas des hémorroïdes externes (= n'existent pas !)

Un exemple d'anomalie structurelle du rectum est la rectocèle, souvent retrouvée chez la femme âgée : lorsqu'elle pousse pour déféquer, une partie du rectum fait protrusion dans le vagin, créant une poche qui stocke une partie des selles et empêche leur expulsion ! Les patientes n'arrivent alors jamais à complètement vider leurs selles (« Je n'arrive jamais à me vider complètement ») et vont parfois s'aider de leurs mains pour repousser le rectum qui fait protrusion

1.1) Anamnèse

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt, son pantalon et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse actuelle :

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation des symptômes :

- 1) Constipation, incontinence (combien de temps peut-il se retenir après l'appel ?)
- 2) Aller à selles
 - 2.1) Combien de temps (normal jusqu'à 5 minutes) (bloque le retour veineux et fait gonfler les hémorroïdes)
 - 2.2) Sort tout seul ou demande de se lever, d'utiliser les mains pour pousser dans le vagin, etc.
 - 2.3) Qualité/agressivité du nettoyage (peut provoquer une dermatite péri-anale)
- 3) Selles :
 - 3.1) Changement par rapport à avant
 - 3.2) Fréquence et régularité (normal : entre 3 par jour et une fois tous les 3 jours)
 - 3.3) Consistance (saucisson, bloc de marbre, pétoles, etc.) (selon score de Bristol)
 - 3.4) Couleur (hématochésie (= sang frais dans les selles), méléna (selles noires à cause d'une hémorragie du tractus digestif supérieur ou d'un excès de fer (≠

méléna))

- 3.5) Odeur (ex. : pancréatite qui provoque une stéatorrhée qui rend les selles très odorantes)
- 3.6) Sang (dans la cuvette ? Sur le papier ? Mêlé aux selles ?)
- 3.7) Date des dernières selles
- 4) 4 signes cardinaux en proctologie :
 - 4.1) Douleur
 - 4.2) Saignement
 - 4.3) Prurit
 - 4.4) Protrusion

1.2) Inspection

Pour décrire une découverte, on utilisera le système de l'horloge : si on se représente le patient sur le dos avec l'anus face à soi, 12h pointe vers le ciel et 6h vers le sol. Quelle que soit la position du patient (ex. : couché sur le côté), 12h reste « antérieur » et toutes les autres heures aussi !

- Peau péri-anale :
 - Rouge ? Irritée ? Pourrait être une dermatite péri-anale, c'est-à-dire lorsque les personnes se nettoient trop agressivement après être allées à selle
 - Fissure
 - Marisque
 - Hémorroïdes internes
 - Thrombose péri-anale
 - Selles
 - Abcès
- Sous-vêtements :
 - Sales ? Si la personne est incontinente, on peut avoir un problème de dys-coordination : normalement, le muscle pubo-rectal est contracté pour tirer le rectum à 90° et le sphincter externe est tendu pour empêcher les selles de sortir. Un problème d'un de ces deux muscles, par exemple « l'open anus » (une partie du sphincter externe est relâchée (physiologique dans l'âge avancé) et ce muscle n'assure plus son rôle => ils contractent les fessiers pour retenir les selles), peut induire une incontinence
- Test fonctionnel
 - Demander au patient de fermer son anus et de pousser ; si c'est pathologique, on pourrait soudainement voir des hémorroïdes sortir ou un prolapsus du rectum

1.3) Palpation

Si un patient se plaint de douleurs/troubles anaux : toujours lui faire un TR ! « Il n'existe que deux cas de figure où on n'effectue pas de TR : si le patient n'a pas d'anus ou si on n'a pas de doigt »

- TR :
 - Demander au patient de se mettre en décubitus latéral, les jambes légèrement repliée
 - Mettre un gant et beaucoup de gel
 - Glisser gentiment le long de son anus et enfoncer son doigt
 - Présence de selles ; normalement, l'ampoule rectale n'est remplie qu'au moment de la défécation, donc une présence de selles est anormale !
 - Palper tout le sphincter anal
 - Taille
 - Symétrie
 - Tumeur (50% des cancers du rectum palpables !)
 - (Jamais de remarques sur le tonus, car il diminue avec l'âge !)
 - Palper la prostate chez l'homme (lisse avec 2 lobes)
 - Palper les 4 quadrants
- Anuscopie :
 - On enfonce gentiment l'anuscopie dans l'anus pour l'examiner ; on recherche ici surtout des hémorroïdes

(1.4) Investigations supplémentaires)

Elles ne sont à effectuer que si on veut des résultats approfondis, souvent en vue d'une opération, mais ne sont quasiment jamais faites. Permettent de déterminer les (rares) problèmes structurels et fonctionnels (faire de la physio/bio-feedback).

- Rectoscopie (explore jusqu'à 20cm est nécessite un practoclyss¹)
- Endosonographie anale (sphincter intact (surtout épisiotomies abîment) ? Abscès ? Fistule ?)
- Manométrie (perception, volume rectal, compliance)
- Défécographie standard (assis avec Rx)
- Défécographie IRM (couché)

1.5) Tableaux cliniques typiques

Dans plus de 90% des cas, concernant tout ce qui concerne la proctologie (fissures anales, hémorroïdes, etc.), le simple fait de s'intéresser aux 4 signes cardinaux (saignement, prurit, douleur et protrusion) permet de poser le diagnostic, sans même avoir à examiner !

- Hémorroïdes
 - Anamnèse : présence de sang dans les toilettes (75%), mais pas sur le papier, grattent (25%), ne font pas mal (10% font mal) et peuvent faire protrusion (10%). On peut retrouver une altération des selles (constipation ou diarrhée), des

¹ Petit lavement

grossesses, accouchements par voie basse, travail assis, vélo, équitation, de longues périodes assises sur les toilettes, etc.

- Clinique : demander de pousser tout en maintenant son anus fermé, ce qui peut faire sortir les hémorroïdes
- Degré hémorroïdaires : I = on ne peut les voir qu'à l'anuscopie, où on remarque que les coussinets artéro-veineux sont un peu agrandis, II = visibles uniquement quand on pousse et rentrent tout seuls, III = visibles uniquement quand on pousse et ne rentrent pas tout seuls et IV = visibles et permanence et ne rentrent pas
- Attention : les hémorroïdes sont un « prolapsus » de l'anus, formant des petits coussinets radiaires, à ne pas confondre avec un prolapsus du rectum, qui lui forme un tube entier (= circulaire) !
- Marisques :
 - Anamnèse : grattent, font protrusion hors de l'anus, sont indolores et ne saignent pas
 - Clinique : simples replis de peau (jusqu'à 2cm !) bénins (= jamais malins et ne peuvent pas le devenir), à ne pas confondre avec les hémorroïdes !
- Cancer de l'anus :
 - Anamnèse : dur, ulcéré, souvent indolore et peut faire protrusion. Il est très irrégulier et à ne pas confondre avec les hémorroïdes !
- Fissure anale :
 - Anamnèse : saignement anal après les selles, sang sur le papier, mais pas dans les toilettes, douleurs à la défécation seulement, selles dures, ne gratte pas, absence de protrusion. Triade classique (reflète le cercle vicieux dans cette maladie) : constipation chronique, saignement sur le papier et douleurs lors de la défécation
 - Clinique : à l'inspection, on remarque la fissure (90% du temps en postérieure, c'est-à-dire à 6h) = le diagnostic est posé !
 - Chronique (> 6 semaines) : 4 signes de la fissure anale chronique : (1) papille anale hypertrophique, (2) bords enfouis, (3) sphincter à nu et (4) marisque sentinelle
- Abscess anal :
 - Anamnèse : fesses douloureuses au toucher et lorsqu'il s'assied, pas de problème au niveau des selles, de démangeaison, de sang ou de protrusion
 - Clinique : on repère une grosse masse fluctuante (= collection de pus, autrement on a un phlegmon, à traiter uniquement pas AB) proche de l'anus (mais peut aussi avoir une forme de fer à cheval). On peut trouver ces abcès dans 4 endroits : dans la fosse ischio-rectale (le plus souvent), en inter-sphinctérien, péri-anal ou finalement en supra-élévateur
- Fistule anale :
 - Anamnèse : souvent après une opération d'abcès (10% à 25% des abcès ne guérissent pas !), avec du liquide (purulent ou non) coulant toujours par un petit orifice qui ne s'est jamais complètement fermé. Il peut exister des petits saignements

- Thrombose des veines péri-anales :
 - Anamnèse : douleur subite, intense, avec l'apparition d'une voussure, mais sans prurit et sans saignements
 - Clinique : visibles au premier coup d'oeil !
- Kyste sacro-coccygien = kyste pilonidal = sinus pilonidal :
 - Anamnèse : douleur dans la ligne inter-fessière (peut être aiguë ou chronique), touche surtout les hommes poilus (= du sud) sous 30 ans. L'obésité et la position assise de longue durée sont deux facteurs risque
 - Clinique : abcès dans cette région, présence de pertuis (= petits trous dans la peau, ici dans la région de la ligne inter-fessière)
- Prolapsus rectum
 - Anamnèse : incontinence, prolapsus de quelque chose de circulaire hors de l'anus, gratte parfois, saigne parfois sur le papier, ne fait pas mal du tout et touche plus fréquemment les femmes âgées (souvent des années après une hystérectomie)
 - Clinique : protrusion bien visible du rectum, qui forme un cylindre (à ne pas confondre avec des hémorroïdes)

2) Examen gynécologique

Généralités :

Bonnes questions à poser : « Êtes-vous en couple (et pas « Avez-vous un copain ? ») ? » ; « Beaucoup de femmes qui viennent me voir se demandent si ... est normal ; serait-ce également votre cas ? » ; « Êtes-vous satisfaite de votre sexualité ? »

Tout d'abord, il faut préciser qu'il n'est pas utile d'effectuer un examen gynécologique chez une jeune patiente (= < 18 ans) sans plainte (ex. : aménorrhée, brûlures, douleurs, etc.) ; on n'effectuera un examen gynécologique que s'il y a une plainte ou si la patiente désire la pose d'un stérilet. Cependant, à part la pose du stérilet, l'examen gynécologique n'est pas indiqué pour prescrire une contraception (faire une bonne anamnèse remplace alors l'examen) !

Chez les femmes plus âgées (= > 18 ans), l'examen doit par contre être périodique, surtout dans le but de les rassurer, de faire un suivi gynécologique post-accouchement ou encore de dépister les risques de cancer du col utérin.

Le dépistage du cancer du col utérin devrait être commencé dès les 21 ans, puis poursuivi tous les 2 ans jusqu'à 29 ans, puis tous les 3 ans jusqu'à 70 ans. Ce dépistage est fait peu importe si la patiente est vaccinée ou non. Le dépistage s'arrête dès les 70 ans ou si la patiente a subi une hystérectomie pour une indication bénigne.

Tout l'examen gynécologique doit respecter la patiente autant que possible, en essayant d'instaurer un climat de confiance et en cherchant à la brusquer le moins possible (ex. : montrer ce qu'est un spéculum, une chaise gynécologique, permettre de se déshabiller derrière un paravent, etc.). De plus, un examen gynécologique (évidemment avant d'être installé sur la chaise gynécologique) est l'occasion idéale pour aborder la sexualité de manière approfondie (= pas seulement « Et sinon, la pilule, ça marche bien ? »), beaucoup de femmes ayant cette attente. On peut également toucher au thème des violences.

Le climat doit être chaleureux et sympathique pour la patiente, l'invitant à s'ouvrir à son médecin,

mais il est strictement interdit d'entretenir une relation plus que professionnelle avec sa patiente, même amicale ! Ainsi, il faut se méfier des patientes séductrices ou des patientes souffrant de maladies psychiatriques !

Séquence de l'examen :

- 1) Examen visuel de la vulve
- 2) Introduction du spéculum
- 3) Visualisation du col utérin, des parois vaginales et éventuellement prélèvement
- 4) Retrait du spéculum
- 5) Toucher vaginal bimanuel à la recherche du col utérin, de l'utérus et des annexes
- 6) Discussion des résultats avec la patiente

3) Examen uro-génital

Note : une masse palpable dans les reins peut être cancéreuse, mais également une maladie de la jonction, des kystes rénaux, etc.

3.1) Anamnèse

Note : l'anamnèse des problèmes de l'appareil urinaire haut (= reins et uretères) est souvent relativement vague, les symptômes sont plutôt rares et les examens cliniques sont plutôt non-contributifs, alors que dans l'anamnèse des problèmes du tract urinaire bas (= vessie, prostate et urètre) les symptômes sont fréquents et les examens cliniques sont contributifs !

0) Entrée :

- Se désinfecter les mains
- Saluer le patient et se présenter
- Demander au patient la confirmation de son identité
- Expliquer la situation (= annoncer pourquoi on est là et quel examen on va faire) et demander l'accord du patient
- Demander au patient d'enlever son T-Shirt, son pantalon et de s'asseoir. Les femmes n'ont pas besoin d'enlever leur soutien-gorge pour cet examen

1) Anamnèse actuelle :

- « Dites-moi ce qui vous amène ? »

2) Caractérisation des symptômes :

- Caractérisation de la douleur² (= les 7 points)
- **Fièvre**
- Urines (fréquence, quantité, couleur et odeur)³

² Note : des douleurs lombaires aspécifiques sont souvent dues à des pathologies non-urinaires

³ En cas d'hématurie, cf. 5) Examens complémentaires

- Miction (volontaire, sans poussée, rapide, pas > 6 fois/jour, vidange complète de la vessie)
- Douleur aux reins
- Fonctions sexuelles, libido, douleurs
- Développement des caractères sexuels et fertilité
- Pertes vaginales
- Menstruations (début, fin, aménorrhée et dysménorrhée)

3) LUTS (= Lower Urinary Tract Symptoms) :

- Symptômes irritatifs :
 - Pollakiurie
 - Algurie
 - Nycturie
 - Urgenturie/impériosités
- Symptômes obstructifs⁴ :
 - Dysurie/Valsalva
 - Jet diminué
 - Jet intermittent/Dribbling
 - Latence mictionnelle
 - Sensation de vidange vésicale incomplète
- Incontinence (d'effort, de toux ou d'urgence)

4) Anamnèse personnelle⁵ :

- MST et autres maladies
- Antécédents chirurgicaux
- Antécédents obstétricaux ou gynécologiques (= poids des bébés, épisiotomies, hystérectomie, etc.)
- Maladies neurologiques ou métaboliques (= SEP, neuropathie diabétique, lésions ME, AVC, etc.)
- Médicaments

5) Examens complémentaires :

- En cas d'hématurie : épreuve des 3 verres : sang dans le premier verre = hémorragie urétérale ou prostatique ; sang dans le dernier verre = hémorragie vésicale ; sang dans tous les verres = hémorragie rénal ou importante
- En cas de trouble mictionnel :

4 Attention piège : on peut avoir une augmentation de la fréquence des urines en cas d'obstruction ! En effet, la vessie ne se vide plus complètement, mais le jet sera par contre plus fin/demandera davantage d'effort !

5 Très importante dans les incontinences !

- Débitmétrie
- Résidu post-mictionnel avec US

3.2) Examen chez la femme

Identique à l'examen de l'abdomen + examen des reins (palpation et percussion) + gynécologique !
On peut également palper la vessie soit directement, soit de manière bi-manuelle.

À l'anamnèse, il faut rajouter :

- Dernières règles
- Grossesse
- Pertes vaginales
- Prurit vaginal

3.3) Examen chez l'homme

Note : l'anamnèse concernant les organes génitaux externes est très importante chez l'homme, car les symptômes sont fréquents et les examens cliniques contributifs !

Inspection :

- Examen clinique général (pilosité, développement des organes génitaux externes, gynécomastie, etc.)
- Examen du pénis
 - Frein court : au repos, le pénis est tiré vers l'avant
 - Phimosis : étroitesse de l'anneau prépuce, ce qui empêche de découvrir le gland
 - Paraphimosis : étroitesse de l'anneau prépuce, qui une fois ramené à l'arrière du gland, étrangle ce dernier
 - Déviations congénitales
- Testicules :
 - Position (fertilité et cancers !)
 - Volume des testicules ($N > 15\text{ml}$)

Palpation :

- Vessie
- Reins
- Testicules :
 - Hydro- ou spermatocele
 - Varicocèle⁶

6 Différenciée de l'hydrocele par transillumination : blanc si eau, rouge/opaque si sang

- Torsion testiculaire
- Cancer
- TR

3.4) Tableaux cliniques typiques

Système urinaire haut :

- Douleur rénale (ex. : pyélonéphrite) : douleur sourde, en arrière ou sous le rebord costal, elle peut irradier en avant vers l'ombilic
- Pyélonéphrite :
 - Anamnèse : fièvre (fréquente, alors qu'elle est rare dans les cystites !), douleur dans le flanc, nausée/vomissements et éventuellement cystites pouvant l'accompagner (car contamination de l'urine qui s'infecte). Le patient peut se plaindre de douleurs lombaires à la vibration et/ou aux chocs (ex. : descendre les escaliers)
 - Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente, sauf éventuellement à la palpation bimanuelle des loges rénales. On retrouvera par contre de vives douleurs lorsqu'on soumet le patient à des vibrations (ex. : lorsqu'il est couché, passer une main au niveau du rein et gentiment pousser le rein vers nous ; on peut aussi le faire lorsque le patient est assis et qu'on le secoue/balance un peu) ou à la percussion des loges rénales
 - Remarque : si on oublie la palpation ou la percussion des reins, on peut passer à côté d'une pyélonéphrite, car cette douleur peut parfois mimer celle d'une appendicite ! De plus, une pyélonéphrite obstructive (= pyélonéphrite sur obstruction par un calcul rénal) est une urgence médicale, à traiter le plus rapidement possible par néphrostomie, au risque de perdre le patient en quelques heures !
- Colique néphrétique :
 - Anamnèse : douleur intense, qui naît au niveau de l'articulation costo-vertébrale et suit le trajet urétéral, jusque dans les lèvres/bourses, parfois même jusqu'à la cuisse. On rencontre souvent des vomissements avec ! Peut se déplacer avec le temps jusqu'à atteindre ce tableau
 - Clinique : ventre totalement souple, sans défense ni détente
 - Remarque : des douleurs coliques sans trouble du transit apparent doivent toujours faire penser à des coliques néphrétiques ! De plus, une douleur chronique, dans le dos, qui répond à la palpation profonde et aux vibrations des reins (cf. C. !) doit faire penser à une lithiase chronique !
- Lésion des uretères :
 - Anamnèse : souvent opération gynécologique ou colorectale précédente, accompagnée de fortes douleurs
 - Clinique : défense et détente dans la partie du ventre adjacente à la lésion urétérale
- Obstructions (reflux, tumeur urothéliale, méga-uretère, etc.)

Système urinaire bas⁷ :

- Globe vésical/RUA (Rétention Urinaire Aigüe) :
 - Anamnèse : douleur sus-pubienne + masse avec matité + besoin horrible d'aller uriner. Chez une personne âgée, peut ne se manifester que par un état confusionnel. Si le patient se met soudainement à perdre quelques gouttes d'urine (= miction par regorgement), c'est très mauvais signe, car cela indique que la vessie n'arrive plus à supporter la pression !
 - Remarque : dans les causes les plus fréquentes, on retrouve les obstructions (HBP, cancer de la prostate, etc.), les vessies neurogènes (spina bifida, sclérose en plaques, trauma médullaire, syndrome de la queue de cheval, chirurgie abdominale, etc.) et médicamenteuses (neuroleptiques anticholinergiques)
 - Clinique : douleur à la palpation, matité à la percussion, masse sus-pubienne
- Sténose urétrale :
 - Anamnèse : infections urinaires à répétition, dysurie, RUA. Peuvent venir de sondages ou auto-sondages mal réalisés ou de MST
- Vessie neurogène avec RUA :
 - Anamnèse : spina bifida, canal lombaire étroit, hernie discale lombaire, etc.
- Cystite :
 - Anamnèse : algurie, pollakiurie, pyurie et urgenturie avec urines nauséabondes et rarement de la fièvre (grosse différence avec la pyélonéphrite !)
 - Clinique : parfois douleur sus-pubienne
- Urétrite :
 - Anamnèse : asymptomatique dans 40% (surtout chez les femmes), on peut retrouver un écoulement purulent, prurit et algurie. On peut également retrouver la triade de Reiter : arthrite + conjonctivite + urétrite
- Prostatite bactérienne :
 - Anamnèse : douleurs périnéales ou des bourses (~ 50/50) avec pollakiurie, dysurie et algurie
 - Clinique : effectuer un toucher rectal et voir le patient sauter au plafond à la palpation
- Torsion testiculaire :
 - Anamnèse : douleur atroce (10/10) d'apparition brutale (paf !), sans fièvre, touchant surtout les jeunes adultes
 - Clinique : impossible de toucher le testicule (fait trop mal) et réflexe crémastérien aboli
 - Remarque : en cas de doute (c'est-à-dire quasiment toujours), toujours effectuer

⁷ Majoritairement composée de symptômes irritatifs (pollakiurie, urgenturie, algurie et nycturie) ou obstructifs (dysurie, latence mictionnelle, jet fin, jet saccadé, sensation de vidange incomplète et efforts de poussée abdominale)

une exploration chirurgicale le plus vite possible (= dans les 6 heures) !

- DD orchi-épididymite : cf. tableau du bas
- Orchi-épididymite :
 - Anamnèse : douleur atroce (10/10) d'apparition progressive (quelques heures ou jours), avec fièvre, tous les signes d'inflammation (rouge, chaud et oedématié) touchant surtout les adultes. IST souvent responsables
 - Clinique : impossible de toucher le testicule (fait trop mal) et réflexe crémastérien présent
 - DD torsion testiculaire : cf. tableau du bas

	Orchiépididymite	Torsion du cordon spermatique
Âge de prédilection	Âge adulte	12-18 ans
Fièvre	+++	Non
Douleurs	Progressives Continues	Aiguës Continues/intermittentes
Réflexe crémastérien	Présent	Absent
Signes fonctionnels urinaires*	++	Non
CRP	Augmentée	Normale

* = pollakiurie, urgenturie, algurie, hématurie, etc.

- Varicocèle :
 - Anamnèse : très fréquent et pas gênant, mais peut donner des douleurs ou une infertilité
 - Clinique : diaphanoscopie : le contenu de la boule n'est pas transparent (= du sang) vs dans les hydrocèles où la boule est transparente (= de l'eau)
- Traumatismes